



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y TẾ CÔNG CỘNG
HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

BÀI 3.

TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Tổ chuyên môn Công tác xã hội
Trường Đại học Y tế Công cộng

Chuẩn đầu ra bài học

1. Phân tích tiến trình QLTH trong CTXH

2. Áp dụng tiến trình quản lý trường hợp trong công tác xã hội



Từ viết tắt

- . Quản lý trường hợp (QLTH)
- . Công tác xã hội (CTXH)
- . Đối tượng (ĐT)

Q&A

Theo anh/chị QLTH trong CTXH được thực hiện theo các bước nào?





Nội dung bài học

Tiến trình QLTH Trong CTXH

1. Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng
2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch trợ giúp đối với đối tượng
3. Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng
4. Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp
5. Bước 5: Kết thúc quá trình trợ giúp và lưu trữ hồ sơ

Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng



Ảnh: Trang thông tin điện tử Sở Y tế Quảng Ninh

Q&A

Theo anh/chị trong bước tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng, anh/chị cần làm gì?



Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

* Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông qua hình thức trực tiếp

- Nhân viên CTXH tiếp cận với ĐT để triển khai cung cấp dịch vụ QLTH theo chức năng, nhiệm vụ.
- ĐT chủ động tìm đến nhân viên CTXH để tìm kiếm sự hỗ trợ

*Ban công tác xã hội tại Bệnh viện TW Quân đội
108 tiếp cận trợ giúp Người bệnh*





Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

* Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông qua hình thức gián tiếp

- Gia đình, bạn bè, các cơ quan ban ngành ở địa phương, tổ chức chính trị xã hội, các nhóm thiện nguyện từ cộng đồng....giới thiệu, chuyển gửi ĐT tới nhân viên CTXH
- Tiếp nhận thông qua hồ sơ xã hội, hồ sơ bệnh án của người bệnh...
- Qua đường dây nóng (hotline) của bệnh viện, phòng CTXH...



Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

* Tiếp nhận thông tin

Thông tin hồ sơ tiếp nhận ban đầu của đối tượng

- Thời gian, địa điểm, hình thức tiếp nhận ĐT
- Thông tin nhân khẩu học của ĐT: họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh sống,.....
- Bảo hiểm y tế
- Thuộc nhóm đối tượng nào (trẻ em, NKT, NCT,...)
- Thông tin người thân/người chăm sóc





Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

* Tiếp nhận thông tin

Đánh giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp

- **Nơi ở:** Đang gặp tình trạng vô gia cư, mất chỗ ở hoặc sống trong điều kiện không an toàn?
- **Nguy cơ bị bạo lực:** Có nguy cơ bị bạo lực thể chất/tinh thần/tình dục/kinh tế?
- **Đồ ăn, thức uống:** Thiếu đồ ăn, đồ uống hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn thực phẩm?
- **Tổn thương về thể chất, tinh thần**
- **Bị cô lập/kỳ thị**

CƠ QUAN CHỦ QUẢNTên đơn vị

Ngày tiếp nhận:.....

Mã hồ sơ :.....

PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU*(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội)*

Nhân viên tiếp nhận:

Hình thức tiếp nhận: ☐ Gián tiếp ☐ Trực tiếp**I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Họ và tên:.....

2. Ngày tháng năm sinh: 3. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ ☐ Khác

4. Quê quán:.....

5. Số điện thoại liên hệ:

6. Bảo hiểm y tế: ☐ Có ☐ Không Mã số BHYT:7. Đối tượng thuộc nhóm nào sau đây? *(Ghi chú: có thể 1 đối tượng thuộc một hoặc một số nhóm đối tượng)*

- ☐ Trẻ em ☐ Người cao tuổi ☐ Người khuyết tật
☐ Người nghèo ☐ Nạn nhân bị buôn bán ☐ Người có HIV/AIDS
☐ Nạn nhân bạo lực ☐ Người nghiện ma túy ☐ Người bệnh
☐ Người hành nghề mại dâm ☐ Người có rối nhiễu tâm trí

8. Người thân:

Quan hệ: Số điện thoại:

II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU HỖ TRỢ KHẨN CẤP

STT	Nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp	Có (ghi rõ)	Không
1.	Nơi ở: Đang gặp tình trạng vô gia cư, mất chỗ ở hoặc sống trong điều kiện không an toàn?		
2.	Nguy cơ bị bạo lực: Có nguy cơ bị bạo lực thể chất/bạo lực tinh thần/bạo lực tình dục/bạo lực kinh tế?		
3.	Đồ ăn, thức uống: Thiếu đồ ăn, đồ uống hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn thực phẩm?		
4.	Tổn thương về thể chất?		

5.	Tổn thương về tinh thần: Có nguy cơ tự tử/làm hại bản thân?		
6.	Tổn thương về tâm lý, tình cảm?		
7.	Bị cô lập/kỳ thị		

Những hành động can thiệp đã được thực hiện đối với đối tượng?

.....
.....**III. ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI**

1. Kết luận của nhân viên Công tác xã hội:

☐ Hỗ trợ khẩn cấp ☐ Không hỗ trợ khẩn cấp

2. Biện pháp can thiệp khẩn cấp cho đối tượng

Nhu cầu khẩn cấp của đối tượng	Biện pháp/Dịch vụ cung cấp	Đơn vị thực hiện/cung cấp dịch vụ	Thời gian thực hiện

3. Một số giấy tờ tiếp nhận cùng đối tượng

.....
.....

Ngày.....tháng.....năm.....

Nhân viên CTXH đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng



Thu thập thông tin

- ***Nguồn thu thập thông tin***

- ĐT, gia đình, người thân của ĐT
- Bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể.
- Hồ sơ xã hội (XH): hồ sơ trợ giúp ĐT tại các cơ sở trợ giúp XH, Trung tâm CTXH, Phòng/Tổ CTXH trong bệnh viện...



Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Thu thập thông tin

Phương pháp thu thập thông tin (TTTT)

- *Phỏng vấn/vấn đàm*: Hỏi chuyện lâm sàng
- *Quan sát*: sức khỏe thể chất, tinh thần và thông tin liên quan đến vấn đề ĐT
- *Vãng gia*: Nhân viên CTXH đến tại nhà, tại cộng đồng của ĐT để thu thập và kiểm chứng thông tin.
- *Nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan*: TTTT qua hồ sơ xã hội, hồ sơ bệnh án...



Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Thu thập thông tin

Chuẩn bị thu thập thông tin

- Xây dựng kế hoạch thu thập thông tin
- Thu thập thông tin cơ bản trước từ hồ sơ xã hội, hồ sơ bệnh án...
- Đưa ra được mục tiêu của buổi làm việc
- Lập danh sách và liên hệ với nguồn thông tin cần thu thập
- Chuẩn bị công cụ thu thập thông tin (bảng kiểm quan sát; phiếu hướng dẫn phỏng vấn sâu,...)



Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Thu thập thông tin

Thông tin cần thu thập:

- Vấn đề về sức khỏe thể chất, tâm lý – xã hội của ĐT
- Thông tin về hoàn cảnh gia đình và môi trường sống
- ĐT tìm kiếm và sử dụng dịch vụ can thiệp, trợ giúp nào
- Mong muốn/nhu cầu hiện tại của ĐT
- Mối quan hệ của ĐT với thành viên trong gia đình, cộng đồng, tổ chức mà họ tham gia vào...



Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Thu thập thông tin

Thông tin cần thu thập:



- Thông tin từ cá nhân, cộng đồng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể
- Thông tin về các văn bản pháp luật, chương trình, chính sách hay mô hình dịch vụ
- Thông tin từ các thành viên trong nhóm đa chuyên ngành (bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia y tế khác,...)



Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Thu thập thông tin

Một số lưu ý khi thu thập thông tin

- Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, cách xưng hô phù hợp với người được thu thập thông tin.
- Ghi chép, lưu giữ thông tin một cách trung thực, khách quan, đảm bảo nguyên tắc giữ bí mật thông tin và cần chuẩn bị mẫu ghi chép thông tin chính.





Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Thu thập thông tin

Một số lưu ý khi thu thập thông tin

- Ghi chép đầy đủ thông tin trong buổi phỏng vấn/vấn đàm, quan sát, vãng gia và thông tin trong hồ sơ xã hội, hồ sơ bệnh án (nếu có)...
- Lưu ý nhận biết các dấu hiệu bất thường, những thông tin có sự mâu thuẫn của ĐT
- Ghi chép một cách chi tiết, cụ thể thông tin của ĐT





Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Thu thập thông tin

Một số lưu ý khi thu thập thông tin

- Các mối quan hệ tương tác của ĐT với các thành viên trong gia đình, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp,... của họ.

=> Những nguồn thông tin này sẽ giúp cho nhân viên CTXH **tổng hợp, phân tích, đánh giá vấn đề** của ĐT cũng như các nguồn lực trợ giúp của họ.





Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Thu thập thông tin

Một số lưu ý khi thu thập thông tin

- Ghi chép những đặc điểm hạn chế của ĐT
- Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của ĐT (thính giác, thị giác, ngôn ngữ nói..) để có những cách thức hỗ trợ ĐT trong suốt tiến trình QLTH





Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

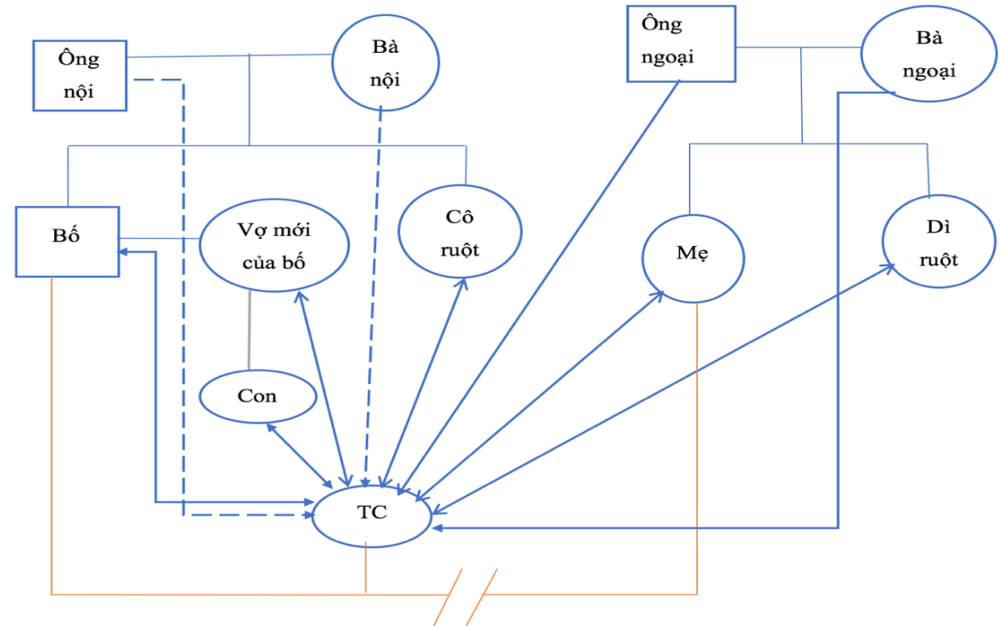
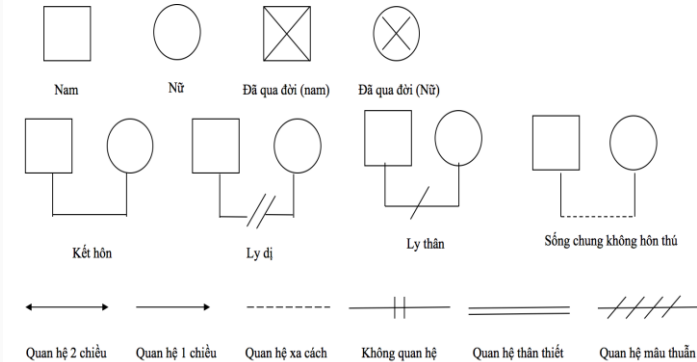
Xác định vấn đề cần hỗ trợ của ĐT

- Xác định nguyên nhân vấn đề (thể chất, tinh thần, từ mối quan hệ tương tác xã hội...)
- Sử dụng công cụ/kỹ thuật xác định vấn đề TC:
 - Vẽ cây vấn đề
 - Biểu đồ/sơ đồ phả hệ
 - Biểu đồ/sơ đồ sinh thái

Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

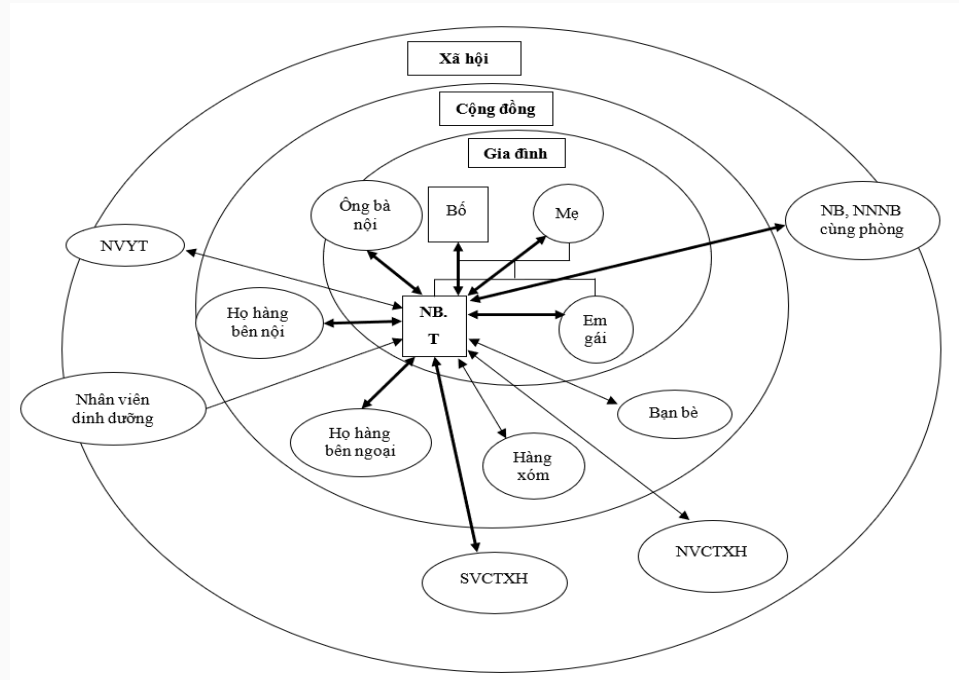
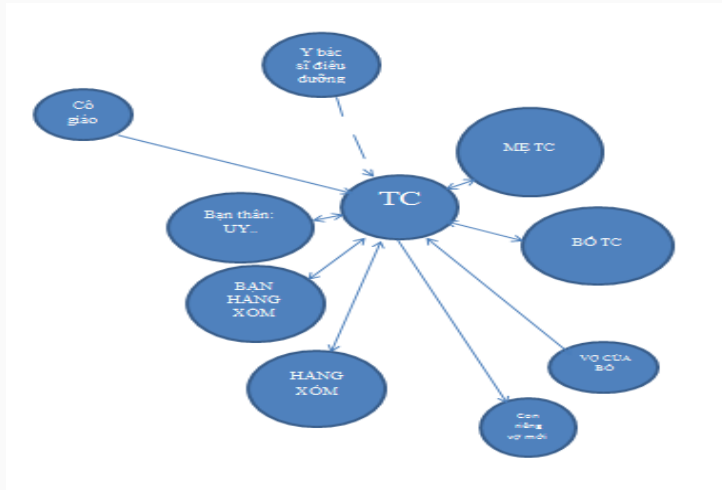
Mẫu sơ đồ phả hệ

Ký hiệu sơ đồ phả hệ



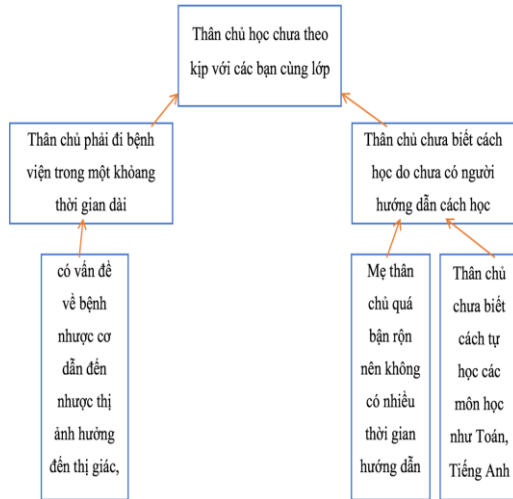
Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Mẫu sơ đồ sinh thái

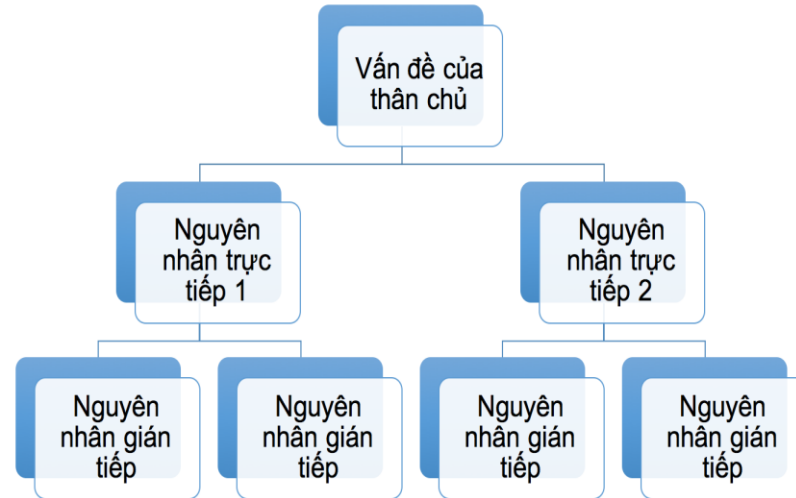


Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Mẫu cây vấn đề



Cây vấn đề





Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Phân tích điểm mạnh và điểm hạn chế

- Nhằm giúp ĐT nhận thức được vấn đề của mình
 - Xác định được điểm mạnh/nguồn lực hỗ trợ và những cản trở/hạn chế trong tiến trình giúp đỡ.
 - Giúp cho ĐT chuẩn bị tâm thế cho việc thực hiện kế hoạch
- => Là căn cứ chính xác cho giải đoạn lập kế hoạch can thiệp/ giúp đỡ



Bước 1: Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng

Sắp xếp thứ tự ưu tiên các vấn đề

- NV CTXH đặt trọng tâm vào ĐT
- ĐT là người cân nhắc và lựa chọn vấn đề ưu tiên
- NV CTXH lưu ý hỗ trợ ĐT
 - Nhận biết mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng của vấn đề của ĐT
 - Các nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài có thể giải quyết vấn đề của ĐT

CƠ QUAN CHỦ QUẢNTên đơn vị

Ngày đánh giá:.....

Mã hồ sơ :.....

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ - XÃ HỘI TOÀN DIỆN*(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội sàng lọc)***I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Họ và tên:.....
2. Ngày tháng năm sinh:..... 3. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ ☐ Khác
4. Quê quán:.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Dân tộc:..... 7. Tôn giáo:
8. Trình độ học vấn:..... 9. Tình trạng hôn nhân:
10. Nghề nghiệp:.....
11. Số điện thoại liên hệ:
12. Bảo hiểm y tế: ☐ Có ☐ Không % được hưởng:
13. Người thân:
- Quan hệ: Số điện thoại:
14. Nhân viên quản lý trường hợp:

II. ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐỐI TƯỢNG GẶP PHẢI

- 1 Rất khủng hoảng 2 Khủng hoảng 3 Tạm ổn
- 4 Ổn 5 Rất tốt

STT	Vấn đề của đối tượng	Mức độ đánh giá				
1.	Sức khỏe thể chất	1	2	3	4	5
2.	Vấn đề tâm lý	1	2	3	4	5
3.	Hoàn cảnh gia đình và môi trường sống	1	2	3	4	5
4.	Hành vi sức khỏe và an toàn	1	2	3	4	5
5.	Nhu cầu chăm sóc	1	2	3	4	5
6.	Mối quan hệ xã hội	1	2	3	4	5

II. THÔNG TIN SỨC KHỎE THỂ CHẤT**1. Vấn đề sức khỏe của đối tượng****2. Hướng điều trị dự kiến****3. Tiền lượng****III. THÔNG TIN VẤN ĐỀ TÂM LÝ – SỨC KHỎE TÂM THẦN****1. Vấn đề tâm lý của đối tượng**

- ☐ Bình thường
- ☐ Căng thẳng (DASS-21): Điểm
- ☐ Trầm cảm (DASS-21/PHQ-9/HADS): Điểm.....
- ☐ Rối loạn lo âu (DASS-21/GAD-7/HADS): Điểm.....
- ☐ Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PCL 5): Điểm.....
- ☐ Có ý định tự tử
- ☐ Khác:

2. Sức khỏe tâm thần của đối tượng

- ☐ Không có vấn đề ☐ Đang điều trị ☐ Đã điều trị
- ☐ Gia đình có tiền sử bệnh tâm thần ☐ Nghiện chất
- ☐ Khác:

3. Trạng thái cảm xúc của đối tượng

- ☐ Bình thường ☐ Thoải mái ☐ Lo lắng
- ☐ Buồn bã ☐ Đau khổ ☐ Sợ hãi
- ☐ Giận dữ ☐ Bối rối ☐ Cô đơn
- ☐ Tuyệt vọng
- ☐ Khác:

IV. THÔNG TIN VỀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG**1. Tình trạng nhà ở của đối tượng**

- ☐ Nhà riêng ☐ Nhà thuê ☐ Không có nhà
- ☐ Khác:

2. Gia đình của đối tượng

- Số lượng thành viên trong gia đình:.....
- Người sống cùng:.....
- Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình:

3. Mức thu nhập trung bình (TB) của gia đình đối tượng
☐ Thấp ☐ TB thấp ☐ Trung bình ☐ TB cao ☐ Cao

4. Người thu nhập chính trong gia đình
☐ Đối tượng ☐ Vợ/chồng ☐ Bố/mẹ ☐ Anh/chị/em
☐ Khác:

5. Gia đình thuộc diện chính sách
☐ Hộ nghèo ☐ Hộ cận nghèo
☐ Gia đình có người khuyết tật ☐ Gia đình có người có công
☐ Khác:

6. An ninh trật tự nơi sinh sống
☐ Rất kém ☐ Kém ☐ Bình thường
☐ An toàn ☐ Rất an toàn

7. Các nguồn lực hỗ trợ
- Những hỗ trợ của cộng đồng với đối tượng:.....
- Những chính sách, chương trình dịch vụ xã hội đối tượng đã hoặc đang được thụ hưởng:
- Nguồn lực khác:

V. THÔNG TIN VỀ HÀNH VI SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

1. Hành vi nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
☐ Nghiện rượu ☐ Nghiện chất
☐ Quan hệ tình dục không an toàn ☐ Lạm dụng thuốc
☐ Không tuân thủ điều trị ☐ Hút thuốc lá
☐ Khác:

VI. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU HỖ TRỢ

Nhu cầu hỗ trợ		Có (ghi rõ)	Không
Hỗ trợ vật chất	Tài chính		
	Cung cấp nơi ở		
Chăm sóc sức khỏe thể chất	Dinh dưỡng		
	Khám chữa bệnh/điều trị		
Chăm sóc sức khỏe tinh thần	Dịch vụ tham vấn		
	Dịch vụ giải tỏa căng thẳng, khủng hoảng		

Chăm sóc tâm lý, tình cảm			
Kỹ năng chăm sóc bản thân	Kỹ năng giải tỏa căng thẳng		
	Kỹ năng sống		
	Kỹ năng khác		
Nhu cầu đào tạo, dạy nghề	Đi học phổ thông		
	Đào tạo nghề		
	Học các khóa chuyên đề nâng cao kiến thức		
Nhu cầu việc làm			
Nhu cầu hỗ trợ pháp lý			
Nhu cầu kết nối tới các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của đối tượng			

VIII. ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Các nguồn lực hỗ trợ
.....
.....
.....

2. Các vấn đề của đối tượng cần hỗ trợ (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)
.....
.....
.....

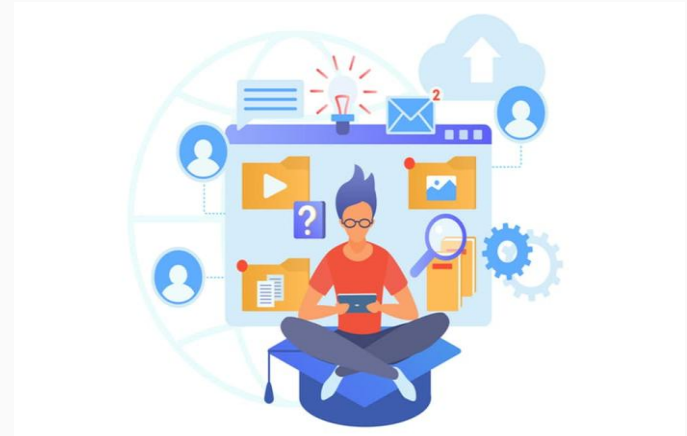
3. Dự kiến các hậu quả nếu đối tượng không được hỗ trợ kịp thời
.....
.....
.....

Ngày.....tháng.....năm.....

Nhân viên CTXH đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bước 2: Xây dựng kế hoạch trợ giúp đối với đối tượng



Q&A

Theo anh/chị để xây dựng kế hoạch trợ giúp đối với đối tượng cần tuân thủ theo nguyên tắc nào?





Bước 2: Xây dựng kế hoạch trợ giúp đối với đối tượng

Nguyên tắc lập kế hoạch

- Đảm bảo sự tham gia của tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan đóng vai trò chính trong tiến trình trợ giúp
- ĐT là người đưa ra các quyết định cuối cùng
- Mục tiêu có thể đo lường được trước khi lập kế hoạch trợ giúp ⇒ Các mục tiêu với chỉ số đo lường rõ ràng sẽ giúp cho lên kế hoạch khả thi và quá trình giám sát, lượng giá được thuận lợi.



Bước 2: Xây dựng kế hoạch trợ giúp đối với đối tượng

Nguyên tắc lập kế hoạch

- Cung cấp dịch vụ trợ giúp đảm bảo tính cá biệt hóa của mỗi trường hợp ĐT
- Các nguồn lực bên trong, nguồn lực bên ngoài, nguồn lực chính thức và các nguồn lực phi chính thức cần được xác định, huy động...
- Đảm bảo được tính liên tục của các dịch vụ tham gia vào hỗ trợ người bệnh.

Q&A

Theo anh/chị để xây dựng kế hoạch trợ giúp đối tượng cần xác định mục tiêu, các hoạt động can thiệp như thế nào?





Bước 2: Xây dựng kế hoạch trợ giúp đối với đối tượng

Xác định mục tiêu hỗ trợ

Một mục tiêu tốt khi đáp ứng các yêu cầu sau (mục tiêu SMART) viết tắt của:

- Specific (Cụ thể);
- Measurable (Có thể đo lường được);
- Action-oriented (Định hướng hành động);
- Realistic (Mang tính thực tế);
- Timely (Kịp thời)

Mục tiêu cần dựa trên vấn đề của ĐT

Mục tiêu hướng tới giải quyết các vấn đề ưu tiên và nhu cầu trước mắt ĐT





Bước 2: Xây dựng kế hoạch trợ giúp đối với đối tượng **Xác định các hoạt động can thiệp của QLTH**

Kế hoạch xây dựng cần đảm bảo được các thông tin chính sau:

- Hoạt động đáp ứng mục tiêu cụ thể giải quyết vấn đề khó khăn của ĐT.
- Ai sẽ là người thực hiện hoạt động này?
- Cần có những nguồn lực nào, nguồn lực nào đang có và cần huy động thêm để thực hiện hoạt động này?
- Thời gian và địa điểm thực hiện các hoạt động?
- Dự kiến kết quả đầu ra từng hoạt động.



**** Chú ý đến các hoạt động vận động, điều phối nguồn lực và phối hợp đa chuyên ngành, liên ngành***

Mẫu kế hoạch quản lý trường hợp



KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP

(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh: 3. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ ☐ Khác
4. Người lập kế hoạch:
5. Thời gian lập:

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Vấn đề/Nhu cầu hỗ trợ. (1)

(2)

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

2.2. Mục tiêu cụ thể

3. Bảng kế hoạch quản lý trường hợp

Mục tiêu cụ thể	Hoạt động	Người thực hiện	Thời gian	Nguồn lực	Kinh phí	Kết quả dự kiến
Mục tiêu 1						
Mục tiêu 2						
Mục tiêu 3						

Đối tượng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm.....

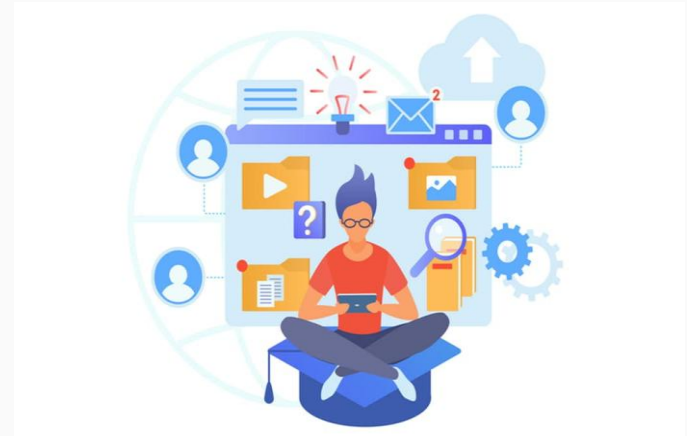
Lãnh đạo đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập kế hoạch

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng



Q&A

Theo anh/chị để thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng cần lưu ý những điểm nào?





Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng



Kết nối, huy động nguồn lực:

- (1) Tạo mối quan hệ giữa các cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ bên trong và bên ngoài đơn vị
- (2) Kết nối chuyên gia, cơ sở dịch vụ cung cấp cho ĐT về kiến thức kỹ năng liên quan đến vấn đề ĐT gặp phải
- (3) Khai thác tiềm năng, phát huy nguồn lực từ các bên tham gia
- (4) Kết nối khuyến khích ĐT tham gia các nhóm đồng đẳng trong và ngoài cơ sở trợ giúp để thực hiện các chức năng: Phòng ngừa, phục hồi và phát triển.



Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng



Thiết lập mạng lưới:

- Tìm hiểu, xác định được các cá nhân, cơ quan tổ chức cung cấp các dịch vụ CTXH trong và ngoài đơn vị/tổ chức
- Các chương trình dự án; các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước; các tổ chức xã hội chính thức và không chính thức...
- Cá nhân/tổ chức/đơn vị trong cộng đồng, xã hội có thể tham gia vào giải quyết vấn đề khó khăn của ĐT.

Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng



Cung cấp dịch vụ công tác xã hội:

- Nhân viên CTXH cần tạo lập mối quan hệ tốt với ĐT.
- Nhân viên CTXH trực tiếp thực hiện cung cấp dịch vụ CTXH thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ mình.
- Kết nối giới thiệu và kết nối ĐT tham gia vào các nhóm đồng đẳng, nhóm trị liệu

Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng

- Phối hợp đa chuyên ngành:**

- Tổ chức phối hợp thực hiện theo nhóm đa chuyên ngành để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh (*NB mắc bệnh hiểm nghèo; NB mạn tính; NB có hoàn cảnh khó khăn;....*).



Nhân viên CTXH



Nhân viên y tế
(*Bác sĩ, điều dưỡng,...*)



**Chuyên gia các
chuyên ngành phù hợp**
(*Tâm lý, dinh dưỡng,...*)

Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng

- Phối hợp liên ngành:**

Tổ chức phối hợp liên ngành giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan, tổ chức khác để giải quyết các vấn đề tâm lý, xã hội của người bệnh (*NB có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực; NB là nạn nhân của bạo lực, xâm hại; NB là nạn nhân của buôn bán người;...*)





Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng

Lưu ý:

Làm việc với gia đình:

- Giữ liên lạc thường xuyên với gia đình;
- Cùng gia đình ĐT phân tích đánh giá cập nhật những nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài
- Huy động sự cam kết, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm của thành viên trong gia đình



Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng

Lưu ý:

Làm việc với cộng đồng:

- Nhân viên CTXH cần có sự kết nối chặt chẽ với cộng đồng nơi ĐT đang sinh sống và làm việc để nhận biết, phân tích và đánh giá được các nguồn lực cũng như khả năng hỗ trợ từ các nguồn lực có thể huy động từ hệ thống trợ giúp tại cộng đồng



Bước 3: Thực hiện kế hoạch trợ giúp đối tượng

Lưu ý:

Làm việc với các cơ quan ban ngành và tổ chức có liên quan

- Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, lĩnh vực chuyên môn của các ban ngành có liên quan có huy động và phối hợp trợ giúp ĐT
- Thông tin về các chế độ, chính sách trợ giúp ĐT
- Trước khi kết nối với các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội thì nhân viên CTXH cần làm việc trước với và những người có liên quan

Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp



Q&A

Theo anh/chị để theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp hiệu quả, nhân viên CTXH cần phải làm gì?





Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

Theo dõi, rà soát

- Theo dõi hồ sơ thông tin, diễn biến tâm lý – xã hội của đối tượng
- Bám sát vào mục tiêu hoạt động và các hoạt động cụ thể đã đề ra.
- Với mỗi mục tiêu và hoạt động cần đưa ra được tiêu chí theo dõi.
- Rà soát lại tất cả các hoạt động cung cấp dịch vụ cho ĐT
- Tổ chức và tham gia trực tiếp vào thảo luận nhóm đa chuyên ngành/nhóm liên ngành về ĐT mà NVCTXH quản lý

•



Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

Theo dõi, rà soát

- Đưa ra được các vấn đề cần lưu ý trong quá trình trợ giúp cho ĐT và người có liên quan
- Thực hiện theo dõi các hoạt động và báo cáo về sự thay đổi của ĐT
- Sử dụng các công cụ, phương tiện thông tin liên lạc để kiểm tra, theo dõi tiến trình thực hiện hoạt động ĐT
- Kết quả giám sát cần được ghi chép, lưu giữ lại trên những công cụ, trên bảng/biểu theo dõi, giám sát.

•

Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

Mẫu phiếu theo dõi diễn biến tâm lý – xã hội của đối tượng

PHIẾU THEO DÕI DIỄN BIẾN TÂM LÝ - XÃ HỘI

(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội)

I. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh: 3. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ ☐ Khác
- Nhân viên quản lý trường hợp:

II. MỤC TIÊU HỖ TRỢ TÂM LÝ – XÃ HỘI

Mục tiêu 1:.....

Mục tiêu 2:.....

III. DIỄN BIẾN TÂM LÝ – XÃ HỘI

Thời gian ¹	Hoạt động hỗ trợ	Diễn biến tâm lý – xã hội đối tượng		Người phối hợp can thiệp	Hoạt động tiếp theo dự kiến
		Tích cực	Tiêu cực		

Ngày.....tháng.....năm.....

Nhân viên CTXH đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Thời gian cập nhật tình trạng sức khỏe, tâm lý, xã hội của đối tượng là mỗi lần gặp đối tượng hoặc tùy thuộc vào vấn đề/ nhu cầu của đối tượng



Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

Lượng giá

- Công cụ lượng giá: Căn cứ vào mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, hoạt động can thiệp, nhân viên CTXH sử dụng công cụ lượng giá phù hợp
 - + Khảo sát định lượng
 - + Hướng dẫn phỏng vấn sâu
 - + Bảng kiểm quan sát
 - + Test sàng lọc phù hợp
 -



Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

Lượng giá

- Kết quả sự thay đổi của ĐT (mức độ vấn đề ĐT gặp phải)
 - Nhận thức của ĐT về vấn đề khó khăn của họ sau can thiệp trợ giúp
 - Về sức khỏe thể chất của ĐT sau can thiệp trợ giúp.
 - Vấn đề sức khỏe tinh thần của ĐT của họ sau can thiệp trợ giúp.
 - Về hành vi: ĐT có những hành vi tích cực, tiêu cực nào liên quan đến các vấn đề giao tiếp, ứng xử, giải quyết bất đồng mâu thuẫn cũng như cách thức giải quyết vấn đề của mình

Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

Lượng giá

Mẫu phiếu đánh giá kết quả can thiệp



CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên đơn vị

Ngày đánh giá:.....

Mã hồ sơ :.....

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP

(Dành cho Nhân viên Công tác xã hội)

I. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG

- Họ và tên:.....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ ☐ Khác
- Ngày đánh giá:

II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VẤN ĐỀ CỦA ĐỐI TƯỢNG

- 1 Rất khủng hoảng 2 Khủng hoảng 3 Tạm ổn
4 Ổn 5 Rất tốt

STT	Vấn đề của đối tượng	Mức độ đánh giá				
1.	Sức khỏe thể chất	1	2	3	4	5
2.	Vấn đề tâm lý	1	2	3	4	5
3.	Hoàn cảnh gia đình và môi trường sống	1	2	3	4	5
4.	Hành vi sức khỏe và an toàn	1	2	3	4	5
5.	Nhu cầu chăm sóc	1	2	3	4	5
6.	Mối quan hệ xã hội	1	2	3	4	5

III. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP

.....
.....
.....
.....

Ngày.....tháng.....năm.....

Nhân viên CTXH đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

Lượng giá

- Tính hiệu quả của từng hoạt động
- Mức độ hài lòng của đối tượng
- Sự tham gia của nhóm đa chuyên ngành và/hoặc nhóm liên ngành (trong trường hợp cần thiết).
- Sự tham gia của các nguồn lực khác: gia đình, cộng đồng,...

•

Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

Lượng giá

Mẫu phiếu đánh giá sự hài lòng

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên đơn vị

Ngày đánh giá:.....

Mã hồ sơ :.....

PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI HOẠT ĐỘNG

(Dành cho Đối tượng)

I. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh: 3. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ ☐ Khác
4. Ngày đánh giá:

Mức độ đánh giá:

- 1 Rất không hài lòng 2 Không hài lòng 3 Bình thường
4 Hài lòng 5 Rất hài lòng

STT	Nội dung đánh giá	Mức độ đánh giá				
1.	Ông/bà có hài lòng về hoạt động Công tác xã hội (CTXH) không?	1	2	3	4	5
2.	Nhân viên CTXH hiểu và hỗ trợ tiếp cận đầy đủ, kịp thời nhu cầu của ông/bà?	1	2	3	4	5
3.	Sự hỗ trợ của nhân viên CTXH đã giúp ông/bà giải quyết vấn đề tâm lý – xã hội?	1	2	3	4	5
4.	Ông/bà đánh giá như thế nào về kỹ năng của nhân viên CTXH trong quá trình hỗ trợ?	1	2	3	4	5
5.	Các hoạt động hỗ trợ phù hợp với sức khỏe thể chất, tinh thần của ông/bà?	1	2	3	4	5
6.	Ông/bà có sẵn sàng giới thiệu nhân viên CTXH tới những đối tượng khác cần hỗ trợ?	1	2	3	4	5

Ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng hoạt động Công tác xã hội?

Người đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bước 4: Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

Điều chỉnh kế hoạch trợ giúp

- Đánh giá điểm mạnh và điểm hạn chế còn tồn tại trong kế hoạch trợ giúp ĐT
- Điều chỉnh kế hoạch phù hợp với ĐT sau khi đánh giá các hạn chế



Bước 5: Kết thúc quá trình trợ giúp và lưu trữ hồ sơ





Q&A

Theo anh/chị việc kết thúc quá trình trợ giúp và lưu trữ hồ sơ được thực hiện như thế nào?





Bước 5: Kết thúc quá trình trợ giúp và lưu trữ hồ sơ

Trường hợp kết thúc QLTH trong CTXH

- Khi ĐT đã đạt được các mục tiêu trợ giúp, các vấn đề và nhu cầu của ĐT đã được giải quyết.
- ĐT được muốn chuyển cơ sở trợ giúp khác
- Kết quả đánh giá các nguồn lực hạn chế không đủ khả năng để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ĐT
- ĐT không muốn sử dụng dịch vụ nữa.
- Không kết nối liên lạc được với ĐT
- ĐT tử vong



Bước 5: Kết thúc quá trình trợ giúp và lưu trữ hồ sơ

Trường hợp chưa kết thúc hoặc cần đánh giá lại vấn đề ĐT

- ĐT đề xuất thay đổi mục tiêu, kế hoạch trợ giúp. Nhân viên CTXH cần đánh giá lại trường hợp của họ, lập kế hoạch trợ giúp khác.
- Nhân viên CTXH nhận biết, đánh giá được các yếu tố nguy cơ gây hại tới ĐT vẫn còn tồn tại hoặc phát sinh tại thời điểm kết thúc.
- ĐT vẫn cần có sự hỗ trợ để được tiếp tục điều trị tại cơ sở y tế



Bước 5: Kết thúc quá trình trợ giúp và lưu trữ hồ sơ

Lưu ý:

- Trước khi kết thúc: Nhân viên CTXH cần thông báo tới ĐT về thời gian kết thúc; giãn dần tần suất tiếp xúc với họ
- Sau khi kết thúc: Vẫn tiếp tục có kế hoạch theo dõi ĐT khoảng thời gian 3 – 6 tháng
- Liên hệ với cộng đồng địa phương trợ giúp cho ĐT tái hòa nhập lại cộng đồng tiếp tục được theo dõi hỗ trợ ĐT
- Nhân viên CTXH cần hoàn thiện hồ sơ và lưu giữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến ĐT



Trường hợp 01:

Bệnh nhân là ông T., 72 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, hiện đang điều trị tại khoa Thần kinh trong tình trạng liệt nửa người trái do nhồi máu não diện rộng. Về mặt y tế, ông T. có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp 2 nhưng kiểm soát kém, hiện tại cơ năng phục hồi chậm, rối loạn nuốt dẫn đến nguy cơ viêm phổi sặc và cần người hỗ trợ hoàn toàn trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADLs). Về hoàn cảnh gia đình, ông sống cùng vợ (69 tuổi, bị thoái hóa khớp nặng, đi lại khó khăn) và gia đình con trai út gồm hai vợ chồng làm công nhân may và một cháu nội 2 tuổi; người con cả sống ở miền Nam và ít khi liên lạc. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào khoản lương hưu 4,2 triệu đồng của ông và thu nhập bấp bênh của vợ chồng con trai, trong khi các chi phí ngoài danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) và tã giấy, sữa cao năng lượng đang trở thành gánh nặng lớn. Về mặt tâm lý, vốn là người từng giữ vai trò quyết định trong gia đình, ông T. hiện rơi vào trạng thái trầm cảm sau đột quỵ, thường xuyên từ chối tập vật lý trị liệu, cáu gắt với vợ và có ý định đòi về nhà "chờ chết" vì không muốn làm khổ con cái. Hệ thống hỗ trợ cộng đồng tại địa phương hiện chỉ dừng lại ở mức thăm hỏi của Hội người cao tuổi, chưa có dịch vụ chăm sóc tại nhà hay trung tâm phục hồi chức năng chuyên biệt, khiến kế hoạch xuất viện của nhóm đa ngành (bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên CTXH...) gặp bế tắc do lo ngại không có người chăm sóc an toàn tại gia đình.

Áp dụng tiến trình quản lý trường hợp để giải quyết trường hợp nêu trên?



Trường hợp 02:

Bé P., 7 tuổi, dân tộc Mông, quê tại một bản vùng sâu thuộc tỉnh Hà Giang, được chẩn đoán mắc Ung thư máu (Lơ-xê-mi cấp dòng lympho) và đang trong đợt truyền hóa chất thứ hai tại khoa Nhi. Hồ sơ y tế cho thấy bé đáp ứng thuốc tốt nhưng thể trạng suy dinh dưỡng độ II, thường xuyên sốt cao do nhiễm trùng cơ hội. Bố mẹ P. là anh S. (29 tuổi) và chị M. (27 tuổi), cả hai đều không nói thạo tiếng phổ thông, trình độ văn hóa thấp và là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã. Rào cản lớn nhất hiện nay là quan niệm về bệnh tật; anh Súa tin rằng con mình bị "ma rừng bắt" do gia đình đã phạm phải điều cấm kỵ khi đi rừng, nên thường lén lút mang bùa chú vào giường bệnh và nhiều lần bày tỏ ý định đưa con về bản để nhờ thầy cúng giải hạn thay vì tiếp tục hóa trị. Về mặt kinh tế, dù P. có BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi (vừa mới hết hạn và đang chờ làm thẻ mới theo diện hộ nghèo), nhưng chi phí ăn uống tại Hà Nội và tiền tàu xe đi lại giữa Hà Giang và Hà Nội đã tiêu tốn số tiền vay mượn từ họ hàng. Sự tương tác giữa nhân viên y tế và gia đình rất hạn chế do bất đồng ngôn ngữ, dẫn đến việc anh chị không hiểu rõ phác đồ điều trị, luôn sống trong sự lo âu, sợ hãi không gian bệnh viện và cảm thấy bị cô lập giữa môi trường đô thị.

Áp dụng tiến trình quản lý trường hợp để giải quyết trường hợp nêu trên?



Trường hợp 03:

Chị M., 34 tuổi, tạm trú tại một dãy trọ gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long, hiện đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình sau một tai nạn lao động nghiêm trọng khiến chị phải cắt cụt 1/3 dưới đùi phải. Chị M. là mẹ đơn thân, nuôi con gái 9 tuổi đang học tiểu học; chị vốn là lao động tự do (giúp việc theo giờ và bán hàng rong), không có hợp đồng lao động và không tham gia bảo hiểm xã hội hay BHYT tự nguyện, dẫn đến việc toàn bộ chi phí phẫu thuật và hậu phẫu hiện đang được những người cùng xóm trọ quyên góp tạm thời. Về tình trạng y tế, vết thương mồm cụt của chị đang lành tốt nhưng chị gặp hội chứng chi ma (đau ở phần chi đã mất) gây mất ngủ kéo dài và suy nhược cơ thể. Về mặt xã hội, chị M. đã cắt đứt liên lạc với gia đình ở quê tại Thanh Hóa từ 10 năm trước do mâu thuẫn về hôn nhân, hiện không có người thân thích để trông cậy ngoài sự hỗ trợ rời rạc từ hội nhóm thiện nguyện trên mạng xã hội. Tâm lý chị hiện cực kỳ khủng hoảng, chị luôn khóc khi nghĩ về việc mình trở thành người khuyết tật, mất khả năng lao động và nỗi sợ hãi tột cùng về việc không thể tiếp tục nuôi con ăn học hoặc bị chủ trọ đuổi vì không có tiền trả phòng. Chị đang rất cần sự trợ giúp để giải quyết các vấn đề.

Áp dụng tiến trình quản lý trường hợp để giải quyết trường hợp nêu trên?



4. Các tài liệu học tập/tham khảo

Tài liệu phải đọc:

- Phạm Tiến Nam, Nguyễn Tuấn Hưng, Nguyễn Hồng Sơn. Quản lý trường hợp tại các cơ sở y tế. NXB Lao động. 2022 (Trang 13–20)
- Slide bài giảng Tổng quan QLTH trong CTXH, Trường Đại học Y tế công cộng, 2024.



4. Các tài liệu học tập/tham khảo

Tài liệu nên đọc:

1. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tài liệu Quản lý trường hợp (Tài liệu hướng dẫn thực hành, dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở). 2016.
2. Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Đỗ Nghiêm Thanh Phương, Nguyễn Thu Hà. Công tác xã hội với học sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần. NXB Giáo dục Việt Nam. 2020.
3. Nguyễn Trung Hải và cộng sự. Giáo trình Quản lý trường hợp với người nghiện ma túy. NXB Lao động Xã hội. 2013.
4. Trần Hữu Trung, Nguyễn Văn Hồi. Tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình Trung tâm công tác xã hội và nghiệp vụ quản lý trường hợp. NXB Thống kê. 2011
5. Arthur J. Frankel, Sheldon Gelman, Diane K. Pastor. Case Management: An Introduction to Concepts and Skills. Oxford. 2019.



Câu hỏi và trả lời nội dung bài học



